GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE
광교바른내과

EASO 2026 비만 약물 알고리즘, 감량 목표와 합병증으로 고른다

Nature Medicine 2026.05 — SURMOUNT-5 등 새 RCT 근거 반영. Tirzepatide와 semaglutide의 역할을 목표 체중감량·합병증 기준으로 재정렬.

Ciudin et al. Nature Medicine 2026 · EASO living framework update

★★★★★

한 문단·세 숫자로 요약

이제 비만약 선택은 '어느 약이 더 세냐'가 아니라 '목표와 합병증이 무엇인가'다.

EVIDENCE BASE

62 RCT · 2025.11.21까지의 새 근거를 반영한 living guidance 업데이트.

SURMOUNT-5

20.2% vs 13.7% · Tirzepatide vs semaglutide 72주 평균 체중감량.

MASH FIBROSIS

Semaglutide · 2026 업데이트에서 fibrosis stage improvement 근거는 semaglutide가 더 강함.

중요한 단서 —

EASO는 알고리즘을 universal ranking이나 처방 순서로 읽지 말라고 명시했다. 환자 특성, 선호, 비용, 안전성을 함께 본다.



비만 환자와 의료진이 체중감량 목표 그래프를 함께 보는 파란색 상담 일러스트

한 문단·세 숫자로 요약

근거 · Nature Medicine 2026 · EASO update · SURMOUNT-5 NEJM 2025

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

2026 업데이트에서 달라진 포인트

체중감량 주목표와 MASH 영역에서 근거 분리가 더 선명해졌다.

Tirzepatide 우위 명확화

합병증 없는 비만에서 체중감량 자체가 주목표일 때 근거가 더 강해졌다.

SURMOUNT-5 반영

직접 비교 RCT로 tirzepatide의 평균 감량 폭과 목표 달성률 우위 확인.

MASH update

MASH remission은 semaglutide 또는 tirzepatide, fibrosis stage improvement는 semaglutide 근거가 더 강함.

Not a ranking

알고리즘은 처방 순서표가 아니라 합병증-목표 기반 의사결정 도구.

Safety domain 예정

향후 업데이트에서 중단율·이상반응 등 benefit-risk 영역이 강화될 전망.

Living guidance

새 약제·경구제·장기 outcome이 나오면 계속 바뀌는 구조.

2026 업데이트에서 달라진 포인트

근거 · EASO press release 2026-05-12 · Nature Medicine 2026

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

직접 비교: tirzepatide가 평균 감량 폭에서 우위

환자에게 '몇 kg'보다 '목표 감량률 달성 가능성'으로 설명하면 명확하다.

핵심 항목	값
평균 감량 Tirzepatide	−20.2%
평균 감량 Semaglutide	−13.7%
≥20% 달성 Tirzepatide	48.4%
≥20% 달성 Semaglutide	27.3%

결과 해석

평균 차이 6.5%p. BMI 35 이상 또는 20% 이상 감량이 필요한 군에서 임상적으로 크다.

연구 주의점

Open-label trial이며 안전성 비교에 powered 된 연구는 아니다.

직접 비교: tirzepatide가 평균 감량 폭에서 우위

근거 · Aronne et al. NEJM 2025;393:26-36 · Lilly release 2025-05-11

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

목표 감량률로 먼저 나누기

환자에게 먼저 물을 질문은 '얼마나 빼야 합병증이 좋아지는가'다.

5-10% · 초기 대사 개선 · 혈당·혈압·지질 개선 목적. 생활요법+약물 선택 폭 넓음. · 10-15% · Semaglutide zone · GLP-1RA 단독으로 충분한 목표. CV 보호 근거도 고려. · 15-20% · 공유 의사결정 · tirzepatide 우선 검토. 비용·부작용·선호도 함께 평가. · ≥20% · Tirzepatide zone · 고도비만·OSA·큰 기계적 부담이 있으면 우선 고려. · BARIATRIC · 수술/다학제 · 약물만으로 부족한 BMI·합병증은 수술 포함 평가.



두 가지 주사 펜 경로가 서로 다른 체중감량 목표로 이어지는 파란색 의사결정 일러스트

목표 감량률로 먼저 나누기

근거 · EASO 2026 framework · SURMOUNT-5

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

합병증별 약물 선택 프레임

체중감량률만 보지 말고, 어떤 합병증을 함께 치료하려는지 본다.

합병증/목표	Tirzepatide	Semaglutide	실무 포인트
체중감량 주목표	근거 우위	강함	큰 감량 필요 시 tirzepatide 우선 검토
심혈관 보호	outcome 진행 중/제한	SELECT 등 근거	ASCVD 동반이면 semaglutide 근거가 강점
OSA + 비만	강점	자료 제한	기계적 감량 효과가 중요
MASH remission	가능	사용 가능	둘 다 고려 가능
MASH fibrosis	덜 성숙	근거 더 강함	fibrosis 개선 목표면 semaglutide 쪽 근거 확인



비만 환자 실루엣 주변에 심장, 간, 수면, 관절 합병증이 배치된 파란색 지도형 일러스트

합병증별 약물 선택 프레임

근거 · EASO 2026 update · Nature Medicine

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

알고리즘을 '순위표'로 읽지 않는다

EASO가 직접 강조한 부분이다. 환자별 맥락이 처방을 바꾼다.

순위표가 아닌 이유

직접 비교는 일부 — 많은 비교는 NMA와 별도 RCT 기반 · 합병증별 endpoint — 체중, MACE, OSA, MASH가 서로 다름 · 부작용과 중단율 — efficacy만으로 결정 불가 · 가격·접근성 — 실제 치료 지속 가능성을 좌우

진료실에서 묻는 질문

목표 감량률 — 10%, 15%, 20% 중 어디인가 · 동반질환 — T2D, ASCVD, OSA, MASH, 관절염 · 이전 경험 — GLP-1RA 부작용·중단 이력 · 비용/선호 — 주사제 수용성과 장기 비용 · 상담 문장 —'더 잘 빠지는 약' 하나로 끝내지 말고, 목표와 동반질환에 맞는 약을 고른다.

> 알고리즘을 '순위표'로 읽지 않는다

근거 · EASO 2026 press release

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

비만약 첫 상담 4단계

약제명을 고르기 전에 목표와 위험을 고정한다.

Baseline phenotype

BMI, 허리둘레, 혈압, A1c, 지질, 간수치, 수면무호흡 증상.

Target setting

3개월·6개월·12개월 목표 감량률과 합병증 목표를 수치화.

Drug fit

tirzepatide/semaglutide/기타 약물, 금기, 비용, 선호도 검토.

Follow-up rule

용량 증량, 위장관 부작용, 근손실 예방, 중단 기준을 사전 설명.

비만약 첫 상담 4단계

근거 · EASO 2026 framework · clinic algorithm draft

효과만큼 중요한 지속 가능성

감량 폭이 커도 중단하면 만성질환 치료가 아니다.

01 · 위장관 부작용 · 오심·구토·변비·설사. 증량 속도와 식사 패턴 조정이 핵심. · 02 · 담낭/췌장 · 담석·췌장염 증상 교육. 심한 지속 복통은 즉시 평가. · 03 · 근손실 · 단백질·저항운동 없으면 체중은 줄어도 기능은 떨어질 수 있음. · 04 · 비용 · 장기 지속 비용을 시작 전에 확인. 중단 후 재증가 가능성 설명. · 05 · 금기 · MTC/MEN2 병력, 임신 계획, 중증 위장관 질환 등 확인. · 06 · 추적 · 체중·허리둘레·A1c·간수치·증상 지표를 같은 방식으로 반복 측정.



주사 펜, 식사, 운동, 달력이 순환 화살표로 연결된 장기 비만 치료 일러스트

효과만큼 중요한 지속 가능성

근거 · SURMOUNT-5 NEJM 2025 · EASO 2026 update

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

Tirzepatide vs Semaglutide: 실무적 분기

공식 권고를 과장하지 않고, 근거의 강점을 진료실 언어로 바꾼다.

Tirzepatide를 먼저 떠올릴 때

≥20% 감량 목표 또는 BMI 35 이상 고도비만 · OSA·관절부하 등 기계적 체중 부담이 핵심 · 기존 GLP-1RA 반응 부족 또는 목표 미달 · 큰 허리둘레 감소가 필요한 대사위험군

Semaglutide가 더 설득력 있을 때

10-15% 목표로 충분한 환자 · ASCVD 위험에서 CV outcome 근거를 중시 · MASH fibrosis 개선 근거를 우선 고려 · 약제 접근성·비용에서 현실성이 높은 경우 · 중립 문장 —'체중 감량 폭은 tirzepatide가 더 크지만, 심혈관·간질환 등 목표에 따라 semaglutide 근거가 더 중요할 수 있습니다.'

Tirzepatide vs Semaglutide: 실무적 분기

근거 · EASO 2026 update · SURMOUNT-5 NEJM 2025

한국 외래에서 바로 쓰는 선택표

환자 질문은 대개 '삭센다/위고비/마운자로 중 뭐가 좋나'로 들어온다.

환자상	우선 질문	약물 방향	추적 지표
BMI 30-34	목표 10-15%?	semaglutide 또는 tirzepatide	체중·허리·A1c
BMI ≥35	20% 이상 필요?	tirzepatide 우선 검토	OSA·관절·지방간
ASCVD 동반	CV 보호가 핵심?	semaglutide 근거 강조	MACE risk·BP·LDL
MASH/fibrosis	섬유화 개선 목표?	semaglutide 근거 확인	FIB-4·FibroScan·ALT
비용 민감	지속 가능?	저비용 약제/생활요법 병행	중단 위험·재증가

한국 외래에서 바로 쓰는 선택표

근거 · Clinic implementation draft based on EASO 2026

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

피해야 할 설명

약물 선택을 단순 경쟁 구도로 만들면 장기 치료 설계가 깨진다.

무조건 tirzepatide

체중감량 우위는 명확하지만, 모든 합병증에서 universal first-line이라는 뜻은 아니다.

Semaglutide는 약하다

ASCVD outcome과 MASH fibrosis 영역에서 중요한 근거가 있다.

목표 없는 시작

몇 % 감량을 목표로 하는지 정하지 않으면 약제 평가가 불가능.

부작용 늦게 설명

오심·변비·담낭·췌장 증상은 시작 전 교육해야 중단을 줄인다.

운동 생략

근손실 예방 없이는 체중감량의 질이 떨어진다.

중단 계획 없음

비만은 만성질환. 중단 후 재증가와 유지 전략을 사전에 논의.

피해야 할 설명

근거 · EASO 2026 update

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

진료실 결론

핵심 결과와 한계를 함께 확인합니다.

01 · 큰 감량 목표 — ≥20% 감량이 필요하면 tirzepatide 근거가 가장 설득력 있다. · 02 · 합병증 목표 — ASCVD·MASH fibrosis 등은 semaglutide 근거가 선택을 바꿀 수 있다. · 03 · 알고리즘은 순위표가 아니다 — 환자 특성·선호·비용·부작용을 함께 본다. · 04 · 장기 치료로 설명 — 증량, 부작용, 근손실 예방, 중단 후 유지까지 시작 전에 말한다. · CLINIC NOTE · 광교바른내과 · 의료진 논문 리뷰 · 국내 허가, 공급, 급여, 약가는 시점에 따라 바뀔 수 있어 실제 처방 전 최신 정보를 확인해야 합니다. · 온라인 슬라이드 · QR 스캔

이 자료 다시 보기
광교바른내과 · 의료진 참고자료

논문 결과는 환자 특성과 최신 지침에 맞춰 해석합니다.

근거 · Nature Medicine 2026 · EASO 2026 update · SURMOUNT-5 NEJM 2025